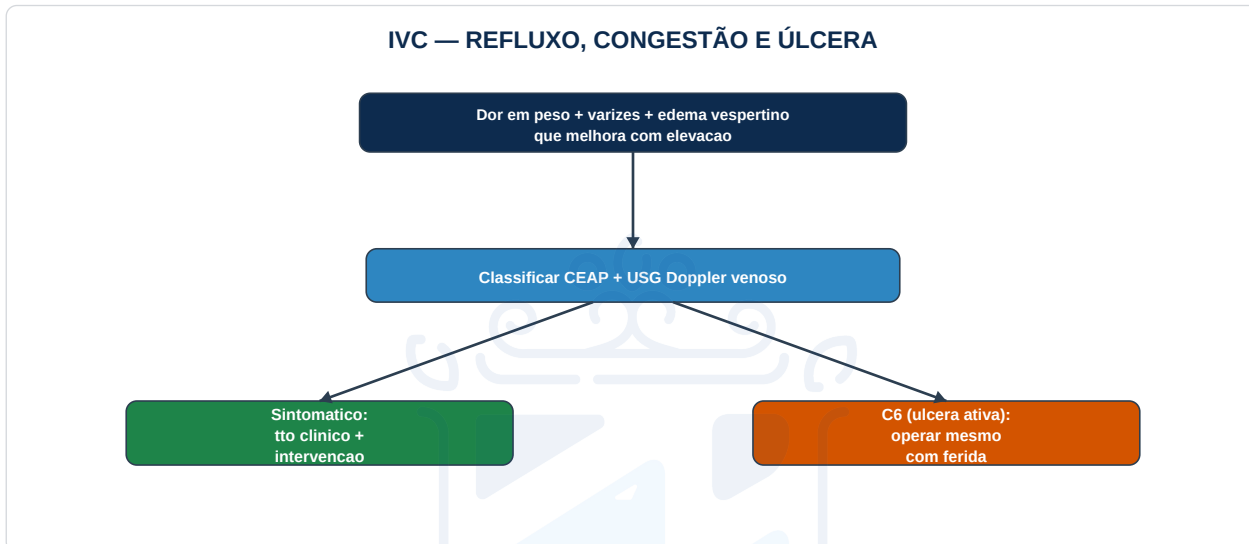


INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA — CEAP

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



ANATOMIA — RETORNO VENOSO

SISTEMAS

- Superficial (~10% do retorno): safena magna, parva e tributárias
- Profundo (~90% do retorno): femoral, poplítea, tibiais -> ilíacas e cava
- Perfurantes: comunicam o sistema profundo com o superficial
- A insuficiência (refluxo) gera congestão e aumento da pressão pós-capilar

O QUE É — FISIOPATOLOGIA E CLÍNICA

IVC

- Doença muito prevalente (>80% em algum grau), na maioria GENÉTICA (varizes em jovens, magros, atletas)
- Refluxo -> congestão -> edema -> infiltração do subcutâneo -> hemossiderina (escurecimento) -> úlcera
- Sintomas: dor em PESO, sobretudo no fim do dia/após ortostase, que MELHORA com a elevação dos membros
- Geralmente acompanha varizes visíveis (raro ser sintomático sem veias visíveis)

CLASSIFICAÇÃO CEAP (clínica)

Classe	Achado clínico
C0-C1	Sem sinais visíveis / telangiectasias e reticulares
C2-C3	Varizes / edema
C4	Alterações de pele (hiperpigmentação por hemossiderina, eczema, lipodermatoesclerose)
C5	Úlcera CICATRIZADA
C6	Úlcera ATIVA (fundo granulado, bem perfundida) + estigmas venosos

PLANEJAMENTO

AVALIAÇÃO ANTES DE TRATAR

- Exame físico + USG Doppler venoso (superficial e profundo)
- Pesquisar insuficiência de safenas e perforantes
- Pesquisar insuficiência do sistema profundo (sequela de TVP, trauma, congênito, compressão central)
- Se safena saudável -> PRESERVAR a safena
- Safena insuficiente -> programar tratamento (concomitante ou não às demais veias)

TRATAMENTO DA SAFENA — TERMOABLAÇÃO x FLEBOEXTRAÇÃO

Método	Vantagens	Desvantagens
Termoablação (laser/radiofrequência)	Melhor estética, recuperação rápida, baixa recanalização	Maior custo
Fleboextração (cirúrgica)	Menor custo, recanalização zero	Pior estética, dor pós-op, mais afastamento
Espuma (polidocanol)	Alternativa a idosos sem condição cirúrgica	Alta falha e complicação local (flebite, mancha)

VEIAS MENORES E COMPLICAÇÕES

NÃO CIRÚRGICO E EHIT

- Reticulares/telangiectasias: escleroterapia (etamolin, glicose, polidocanol) em consultório; CLaCS (criolaser + esclerosante)
- Termoablação preserva pior resultado estético em veias pequenas; combinar técnicas conforme o caso
- EHIT (trombose induzida por calor endotérmico): complicação da termoablação
- EHIT costuma ter comportamento mais benigno que uma TVP verdadeira (classificação/tratamento divergentes)

ÚLCERA VENOSA (CEAP C6) — CONDUTA

TRATAR A INSUFICIÊNCIA É O QUE CICATRIZA

- Paciente C6 deve ser operado MESMO com a ferida aberta
- O tratamento adequado da insuficiência venosa é FUNDAMENTAL para cicatrizar a úlcera
- Base do tratamento clínico: COMPRESSÃO elástica + cuidado da ferida + elevação dos membros
- Sempre associar: atividade física, controle de peso, meia elástica
- NÃO postergar o acompanhamento ambulatorial com o cirurgião vascular

MANEJO CLÍNICO E SEGUIMENTO

BASE DO TRATAMENTO

- ☐ Meia elástica de compressão (pilar do tratamento clínico)
- ☐ Elevação dos membros e atividade física regular
- ☐ Controle de peso
- ☐ Cuidado da úlcera (limpeza, cobertura, compressão) na úlcera venosa
- ☐ Encaminhamento ao cirurgião vascular (sintomáticos se beneficiam de intervenção)

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA O AMBULATÓRIO/VASCULAR

- Paciente com IVC CEAP ____ (varizes/edema/alterações de pele/úlcera).
- Sintomas: dor em peso vespertina que melhora com elevação; varizes visíveis: sim/não.
- USG Doppler venoso: insuficiência de safena/perforantes/sistema profundo ____.
- Conduta: compressão + medidas clínicas; encaminhamento ao cirurgião vascular para programar intervenção (C6 = prioridade).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual sintoma é característico da insuficiência venosa crônica?

- A) Dor em peso nas pernas no fim do dia que melhora com a elevação dos membros
- B) Claudicação que cessa com o repouso independentemente da distância
- C) Dor em repouso que melhora com as pernas pendentes
- D) Dor torácica ao esforço
- E) Dor abdominal pós-prandial

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Na classificação CEAP, o que caracteriza a classe C6?

- A) Telangiectasias
- B) Úlcera venosa ATIVA
- C) Úlcera cicatrizada
- D) Apenas varizes
- E) Edema isolado

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a comparação entre termoablação e fleboextração da safena, é correto:

- A) A fleboextração tem melhor resultado estético e recuperação mais rápida
- B) A termoablação tem melhor estética e recuperação mais rápida, com maior custo
- C) Ambas têm o mesmo custo
- D) A termoablação tem taxa de recanalização zero
- E) A fleboextração dispensa anestesia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com úlcera venosa ativa (CEAP C6) e insuficiência de safena. Qual conduta é correta?

- A) Aguardar a cicatrização completa antes de tratar a insuficiência venosa
- B) Tratar a insuficiência venosa (operar) mesmo com a ferida aberta, pois é fundamental para a cicatrização
- C) Contraindicar qualquer intervenção
- D) Apenas antibiótico sistêmico
- E) Amputação

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o pilar do tratamento clínico da insuficiência venosa crônica?

- A) Anticoagulação plena
- B) Meia elástica de compressão (associada a elevação, atividade física e controle de peso)
- C) Antibiótico contínuo
- D) Repouso absoluto no leito
- E) Corticoide sistêmico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

A IVC cursa com dor em peso/cansaço nas pernas, pior no fim do dia e após ortostase, que MELHORA com a elevação dos membros — oposto da dor isquêmica (que melhora com as pernas pendentes).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

CEAP C6 = úlcera venosa ATIVA (fundo granulado, bem perfundida, com estigmas de doença venosa). C5 é a úlcera já cicatrizada.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A termoablação (laser/radiofrequência) oferece melhor resultado estético e recuperação mais rápida com baixa recanalização, porém maior custo; a fleboextração é mais barata mas com pior estética e recanalização zero.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No C6, opera-se mesmo com a ferida aberta: tratar a insuficiência venosa (refluxo de safena/perfurantes) é fundamental para a cicatrização da úlcera. Compressão e cuidado da ferida acompanham o tratamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A meia elástica de compressão é o pilar do tratamento clínico da IVC, associada à elevação dos membros, atividade física e controle de peso; sintomáticos beneficiam-se de intervenção sobre as veias insuficientes.

SM24
Suporte ao Plantão Médico